

Examen de la motricité et des reflexes

Troubles de la motricité

Dr N. BOULEKROUNE

Plan du cours

- I. Etude de la motricité
 - A. Interrogatoire
 - B. Examen clinique
- II. Etude des reflexes
 - A. Les réflexes ostéo-tendineux
 - B. Les réflexes cutanés-muqueux
- III. Les troubles de la fonction motrice
 - A. Les paralysies
 - B. Les syndromes extra-pyramidaux
 - C. Les mouvements anormaux

Objectifs pédagogiques

1. Citer les signes fonctionnels évocateurs d'une atteinte de la motricité.
2. Dépister et coter un déficit moteur.
3. Décrire les manœuvres de sensibilisation d'un déficit moteur.
4. Décrire les techniques de recherche des réflexes ostéo-tendineux, idiomusculaires et cutanés-muqueux.
5. Connaître les troubles de la motricité.

I. Etude de la motricité

- + La motricité : est une fonction complexe, qui met en jeu un effecteur qui est le muscle strié, sous la commande du motoneurone de la corne antérieure de la moelle épinière (ME), lui-même sous la commande du syndrome pyramidal, extra-pyramidal et système cérébelleux.

- + Elle est impliquée dans :

- Le mouvement
- La coordination des mouvements
- Le maintien de la posture
- Le tonus musculaire.

A. Interrogatoire : recherche

- + **Type de trouble :**

- Une douleur musculaire (myalgie).
- Une fatigabilité musculaire : c'est un déficit moteur qui, absent à la première contraction, n'apparaît que lors de la répétition de l'effort. Évocatrice d'un bloc neuromusculaire.
- Un déficit moteur.

- + **Caractères :**

- Le mode d'installation.
- Le siège.
- Son caractère permanent ou intermittent.

B. Examen clinique :

L'examen musculaire : doit être comparatif, sur un patient dévêtu.

1) Inspection :

- + Trophicité musculaire :

- ❖ Amyotrophie : diminution du volume musculaire.
 - Elle peut être proximale, distale, ou généralisée.
 - Suite à :
 - Lésion du nerf périphérique.
 - Lésion primitive de la fibre musculaire.
 - Par non utilisation du membre (immobilisation plâtrée).
 - Fonte musculaire chez un sujet âgé mais sans faiblesse.
 - Fonte générale se voit en cas de trouble nutritionnel ou une pathologie maligne.
- ❖ Hypertrophie : augmentation du volume musculaire. On observe cette hypertrophie avec certaines myopathies à dystrophie musculaire.

- + Motricité spontanée : est appréciée à l'inspection en dehors de toute sollicitation par l'observation de l'activité gestuelle, de la mimique et de la parole.

- + Mouvements involontaires :

- Fasciculations : contractions involontaires, brèves des fibres musculaires au repos, visible sous la peau sans déplacement.
 - Localisées : dans les lésions nerveuses périphériques.
 - Généralisées : en cas de lésion de la corne antérieure de la ME.
- Asterixis ou Tremor : mouvement répété involontaire autour d'une articulation.

2) Palpation :

- Apprécie la consistance de la masse musculaire : ferme, flasque, rigide.
- Douleur provoquée à la palpation (myosite).

3) Percussion :

- Réflexe idiomusculaire :

- La percussion directe du muscle par un marteau réflexe provoque une contraction, suivie d'une décontraction rapide.
- Il disparaît dans les maladies musculaires.
- Persiste dans les lésions nerveuses périphériques.

B-1 : Tonus musculaire :

- ✚ État de tension (résistance résiduelle) permanent du muscle strié, qui persiste lors de son relâchement volontaire.
- ✚ Il est sous la dépendance de l'activité réflexe médullaire, elle-même sous contrôle supra médullaire (cérébelleux, pyramidal, extrapyramidal).
- ✚ Apprécier le tonus chez un patient allongé sur le dos, le muscle relâché, par la mobilisation passive (sans effort) d'un membre dans toutes les positions possibles.
- ✚ La réponse normale : il n'existe qu'une résistance très faible à la mobilisation passive.
- ✚ Les anomalies peuvent être de 2 types :
- **Hypotonie :**
- ✚ Absence de résistance musculaire lors de la mobilisation passive.
- ✚ Le muscle est flasque avec augmentation de l'amplitude du mouvement articulaire.
- ✚ Elle se voit dans : - l'atteinte cérébelleuse
 - atteinte aigue pyramidale
 - atteinte du système nerveux périphérique.

➤ **Hypertonie ou contracture musculaire :**

- ✚ État de raccourcissement du muscle qui se caractérise par une diminution d'amplitude du mouvement passif.
- ✚ On peut observer 2 types d'hypertonie :
- Hypertonie spastique ou pyramidale :
 - Elle est élective, prédomine aux fléchisseurs et pronateurs aux membres supérieurs et extenseurs et adducteurs aux membres inférieurs.
 - Elle est élastique par augmentation progressive de la résistance avec le degré de l'étirement.
 - Lorsque l'examineur relâche son effort d'étirement, le segment du membre revient à la position initiale.
 - Elle s'accompagne d'une diminution de la force musculaire, d'une exagération des ROT et d'un signe de Babinski.
 - Elle se voit au cours des lésions chroniques du faisceau pyramidal.
- Hypertonie plastique ou extrapyramidale :
 - Caractéristique du syndrome Parkinsonien.
 - La rigidité est continue et homogène pendant tout le mouvement passif.
 - Lorsque l'examineur relâche :
 - le segment reste à la même position, c'est la rigidité en tuyau de plomb
 - si elle cède par à-coup, c'est le phénomène de la roue dentée.
 - Elle ne s'accompagne pas de déficit de la force musculaire, ni de troubles des ROT.

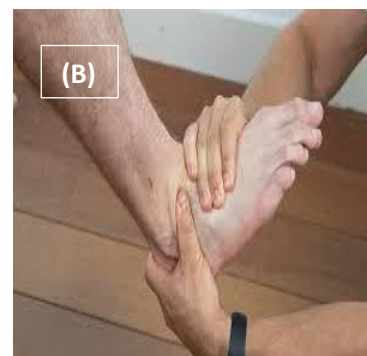
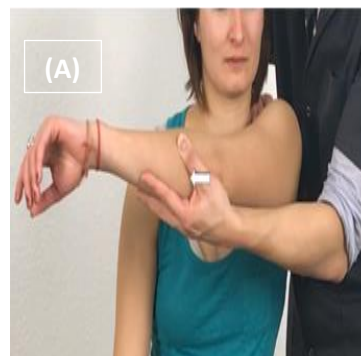
B-2 : Examen de la force musculaire : pourra être appréciée par l'étude des mouvements spontanés et celle de la motricité volontaire

B-2-1 La motricité spontanée

B-2-1 La motricité volontaire : est explorée en demandant au malade d'effectuer systématiquement certains mouvements

✚ **Examen de la force musculaire globale**

- Aux membres supérieurs :
 - Poignée de main
 - Abduction contrariée des bras (A)
 - Flexion contrariée des avant-bras.
- Aux membres inférieurs :
 - Dorsi-flexion contrariée du pied (B)
 - Flexion contrariée du genou et de la hanche.

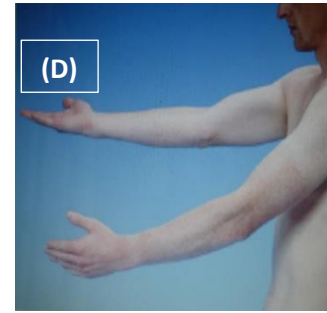


✚ Certaines manœuvres permettront de dépister une paralysie incomplète ou parésie :

➤ Aux membres supérieurs :

■ **L'épreuve des bras tendus :**

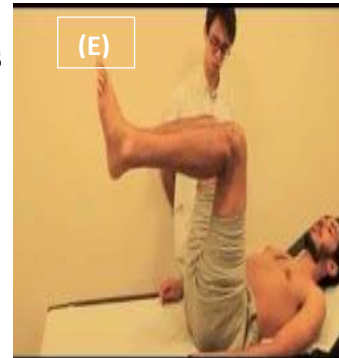
- le patient doit garder bras, avant-bras et doigts écartés, tenus au-dessus du lit. (C)
- il faut attendre 10 à 20 secondes.
- si déficit musculaire → on observe une chute de l'un ou des deux membres (D). Ou il est incapable d'effectuer le mouvement.



➤ Aux membres inférieurs :

■ **Manœuvre de Mingazzini :**

- malade en décubitus dorsal, cuisses et jambes fléchies à angle droit. (E)
- si déficit musculaire → on observe une chute de l'un ou des deux membres.



■ **Manœuvre de Barré :**

- malade en décubitus ventral, jambes fléchies à angle droit sur les cuisses (F).
- si déficit musculaire → on observe une chute de l'un ou des deux membres.

✚ **Examen de la force musculaire segmentaire**

■ Elle est étudiée en demandant au sujet d'exécuter un mouvement contre résistance opposée par examinateur et contre pesanteur → ce qui permet d'apprécier la force musculaire des différentes groupes musculaires de manière bilatérale et comparative des 2 côtés du corps, segment par segment (cou, membres et tronc).

■ Elle est évaluée selon une échelle cotée de 0 à 5.

■ C'est le **Testing musculaire** :

✓ La cotation **0** : pas de contraction musculaire visible

Le muscle est inerte, l'observation et la palpation ne détecte ni mouvement, ni contraction musculaire.

✓ La cotation **1** : contraction musculaire, mais aucun mouvement

Une faible activité contractile est détectée à la palpation et/ou à l'observation (si le muscle est assez superficiel).

✓ La cotation **2** : contraction permettant le mouvement en l'absence de pesanteur

La contraction permet le déplacement du segment dans toute l'amplitude sans mise en jeu de l'effet gravitaire. A défaut, l'amplitude sera partielle.

✓ La cotation **3** : contraction permettant le mouvement contre la pesanteur

Le muscle ou groupe musculaire peut déplacer le segment sur toute son amplitude contre l'action de la pesanteur.

✓ La cotation **4** : contraction permettant le mouvement, contre la pesanteur et résistance

Attribuée à un muscle ou à un groupe musculaire capable d'une action dans toute l'amplitude du mouvement contre la pesanteur et d'accepter une résistance additionnelle d'intensité partielle.

Cependant, le muscle ne parvient pas à déplacer le segment si l'intensité devient maximale, comparable au côté sain.

✓ La cotation **5** : force musculaire normale

Capacité du muscle à accomplir le mouvement dans toute l'amplitude et de vaincre une contrainte d'intensité maximale (comparable au côté sain). De plus, à 5 le muscle devient capable de reproduire l'action plusieurs fois sans s'épuiser.

✚ **Topographie du déficit musculaire**

➤ Parésie : paralysie partielle.

➤ Plégie : paralysie complète.

- Hémiplégie : paralysie des muscles de tout l'hémicorps.
- Paraplégie : paralysie des muscles des membres inférieurs.
- Tétraplégie : paralysie des muscles des 4 membres.
- Monoplégie : paralysie des muscles d'un membre.

II. Etude des réflexes

Ce sont des mouvements involontaires déclenchés par une stimulation tendineuse, cutanée ou muqueuse.

A. Les réflexes ostéo-tendineux (ROT) :

- Réflexe monosynaptique, donc a une valeur localisatrice pour un méramère médullaire concerné.
- Ils se recherchent en percutant le tendon d'un muscle à l'aide d'un marteau réflexe.
- L'examen sera toujours comparatif sur un patient relâché.
- La réponse : est jugée sur la contraction du muscle avec ou sans déplacement articulaire.
- Cette réponse sera analysée dans son amplitude, la symétrie est la règle chez un sujet normal.

➤ Aux membres supérieurs :

1) Réflexe bicipital :

- L'avant-bras en semi-flexion et supination.
- Se recherche en percutant le pousseur de l'examineur placé à plat sur le pli du coude sur le tendon du biceps brachial. (G)
- La réponse est une flexion de l'avant-bras sur le bras par contraction du biceps et du brachial antérieur.
- On teste la racine C5, nerf musculo-cutané.



2) Réflexe stylo-radial :

- L'avant-bras en semi-flexion et le bord radial tourné vers le haut.
- Se recherche en percutant le tendon du long supinateur au-dessus de la styloïde radiale. (H)
- La réponse est une flexion de l'avant-bras sur le bras par contraction du long supinateur.
- On teste la racine C6, nerf radial.



3) Réflexe tricipital :

- L'avant-bras en semi-flexion, maintenu par l'examineur.
- Se recherche par percussion du tendon du triceps brachial au-dessus de l'olécrane. (I)
- La réponse est une extension de l'avant-bras sur le bras par contraction du triceps.
- On teste la racine C7, nerf radial.



4) Réflexe cubito-pronateur :

- L'avant-bras en semi-flexion et en légère supination.
- Se recherche par percussion de la styloïde ulnaire. (J)
- La réponse est une pronation de la main = rotation interne de la main (paume de la main vers le bas).
- On teste la racine C8, nerf ulnaire.



➤ Aux membres inférieurs :

1) Réflexe rotulien :

- Se recherche par percussion du tendon rotulien entre la rotule et la tubérosité tibiale antérieure.
- Patient assis, jambes pendantes (K)
- Ou couché, jambe semi-fléchie soutenue par examinateur.
- La réponse est une extension de la jambe sur la cuisse par contraction du quadriceps.
- On teste la racine L4, nerf fémoral.





2) Réflexe achilléen :

- Se recherche par percussion du tendon d'Achille au-dessus de l'insertion calcanéenne. (L)
- La réponse est une contraction du triceps sural et flexion plantaire du pied.
- On teste la racine S1, le nerf tibial.
- Interprétation de l'examen des ROT : peuvent être soit présents et normaux ou vifs ou abolis.
- ✚ Abolition des ROT : aréflexie, n'a de valeur que si le réflexe idiomusculaire est conservé.
 - Il signe : une atteinte du SNP
 - ou une atteinte brutale SNC (médullaire ou cérébrale), à la phase de début.
- ✚ Exagération des ROT :
 - Vifs : d'amplitude augmentée.
 - Polycinétiques : plusieurs réponses pour une seule stimulation.
 - Diffusés ou extension de la zone réflexogène : la réponse réflexe est obtenue même en stimulant plus loin que la zone réflexogène habituelle.
 - ROT sont exagérés dans le syndrome pyramidal.
 - Vivacité isolée : chez sujet neurotonique (anxieux).

B. Les réflexes cutanés et muqueux :

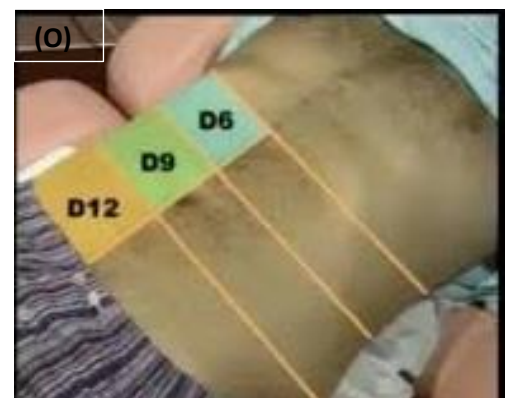
1) Réflexe cutané-plantaire :

- ✚ Se recherche :
 - sur un sujet en décubitus dorsal, la jambe semi-fléchie sur la cuisse.
 - par stimulation non douloureuse du bord externe de la plante du pied d'arrière en avant. (M)
- ✚ La réponse normale : est une flexion du gros orteil et accessoirement les autres orteils.
- ✚ Il n'est interprétable que si l'innervation sensitive et motrice de la plante du pied et des orteils est intacte.
- ✚ Signe de Babinski :
 - La stimulation plantaire entraîne une extension lente et majestueuse du gros orteil avec parfois écartement des autres orteils (signe de l'éventail). (N)
 - En rapport avec une lésion centrale : cortex ou faisceau pyramidal.
 - Il est physiologique chez le nourrisson jusqu'à 2 ans.



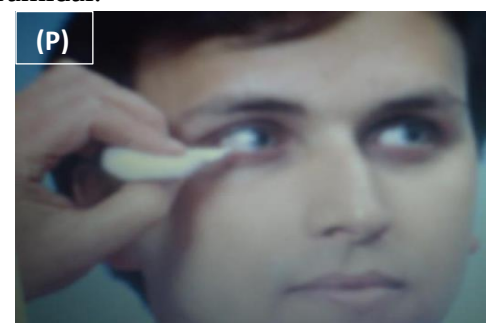
2) Réflexes cutanés-abdominaux (RCA) :

- ✚ Ils se recherchent par une stimulation légère et rapide de la paroi abdominale, sur une ligne horizontale de dehors en dedans, à l'aide d'une pointe mousse. (O)
- ✚ On distingue de chaque côté trois niveaux :
 - RCA supérieur : la stimulation au-dessous du rebord costal, correspondant au métamère D6-D8 de la ME.
 - RCA moyen : la stimulation à hauteur de l'ombilic, correspondant au métamère D8-D10 de la ME.
 - RCA inférieur : la stimulation sous l'ombilic, correspondant au métamère D10-D12 de la ME.
- ✚ La réponse normale : une contraction brève des muscles abdominaux. L'abolition des RCA se voit en cas : de péritonite, lésion du faisceau pyramidal.



3) Réflexe cornéen :

- Excitation de la cornée avec un petit morceau de coton. (P)
- La réponse normale : est un clignement palpébral.
- Aboli si : - lésion du nerf V (branche ophtalmique du trijumeau)
- lésion du nerf VII (nerf facial) et coma (apprécie profondeur).



4) Réflexe vélo-palatin :

- Stimulation de l'hémi-voile par un abaisse-langue.
- La réponse normale : contraction et élévation de l'hémi-voile.

5) Réflexe crémasterien :

- Stimulation cutanée de la face interne de la cuisse.
- La réponse normale : une ascension du testicule homolatéral.
- Aboli en cas : lésion du faisceau pyramidal
lésions intéressant les racines et segments médullaires L1-L2.

6) Réflexe anal :

- Excitation des 4 quadrants de la marge anale du dedans en dehors.
- La réponse normale : contraction du sphincter anal.
- Aboli si syndrome de la queue du cheval.

III. Les troubles de la fonction motrice

- ❖ La motricité est sous la dépendance de plusieurs structures nerveuses : système pyramidal, système extra-pyramidal et cervelet, dont l'intégrité est nécessaire afin que le mouvement puisse s'accomplir de manière normale.
- ❖ Les troubles de la fonction motrice sont de 3 grands types :
 - 1) Les paralysies : qui sont une diminution ou une abolition de la motricité volontaire.
 - 2) Les syndromes extra-pyramidaux : au 1er rang desquels se place le syndrome parkinsonien.
 - 3) Les mouvements anormaux.

A. Les paralysies :

❖ Etude sémiologique des paralysies :

- 1) L'existence d'une paralysie : sera dépistée par l'examen clinique qui va :
 - D'abord apprécier la force musculaire globale.
 - Certaines manœuvres permettront de dépister une paralysie incomplète ou parésie :
 - Aux membres supérieurs : l'épreuve des bras tendus.
 - Aux membres inférieurs : l'épreuve de Barré, l'épreuve de Mingazzini.
 - Lorsqu'un déficit moteur est détecté, on apprécie l'étendue et le degré des paralysies par une étude de la force musculaire de chaque segment paralysé ou force musculaire segmentaire : le testing musculaire.
 - 2) L'examen des réflexes ostéo-tendineux (ROT) et cutanés : doit être systématique.
 - Leur appréciation va permettre de préciser le type de la paralysie.
 - 3) L'examen du tonus : est également indispensable et montrera soit une hypotonie ou une hypertonie.
 - 4) L'examen de la sensibilité doit être systématique.
 - 5) Enfin, on recherchera des troubles trophiques : une atrophie musculaire qui signe l'atteinte du neurone périphérique.
 - 6) Les différents types de paralysies : une paralysie peut être due soit à une atteinte du système pyramidal, soit à une atteinte du neurone moteur périphérique, soit à une atteinte musculaire.
- 6-1) Les paralysies centrales** : sont en rapport avec une atteinte du système pyramidal.
- 6-1-1) 2 types de lésion peuvent être rencontrés :
- Une lésion unilatérale qui siège :
 - le plus souvent sur le trajet intracrânien du faisceau pyramidal : elle réalise une hémiplégie située du côté opposé à la lésion (controlatérale).
 - beaucoup plus rarement, elle peut siéger au niveau de la moelle réalisant une hémiplégie située du même côté que la lésion (homolatérale).
 - Une lésion bilatérale : siégeant au niveau de la moelle qui entraîne une quadriplégie ou plus souvent une paraplégie.
- 6-1-2) Caractères communs :
- Le déficit moteur : est de degré variable, la paralysie peut être complète mais en fait le plus souvent, elle est partielle.

- Elle respecte les muscles à action synergique : muscles du cou, du tronc, du larynx, le diaphragme et les oculomoteurs.
- Elle prédomine sur certains muscles au niveau de chaque segment du corps atteint :
 - A la face : la paralysie prédomine sur le territoire facial inférieur.
 - Aux membres supérieurs : elle intéresse essentiellement les extenseurs et les supinateurs.
 - Aux membres inférieurs : elle atteint les muscles racourcisseurs et les abducteurs.
- Les troubles du tonus sont habituels :
 - Soit hypotonie : dans les atteintes brutales et sévères de la voie motrice principale au stade initial.
 - Soit hypertonie : qui est habituelle au cours des lésions chroniques de la voie pyramidale.
- Les troubles des réflexes :
 - ✓ Les réflexes ostéo-tendineux :
 - L'aréflexie ostéo-tendineuse est habituelle au stade initial des atteintes sévères de la voie pyramidale, elle accompagne l'hypotonie. Elle s'observe également au cours des hypertonies en flexion.
 - L'hyper-réflexivité ostéo-tendineuse est habituelle dans les formes avec hypertonie.
 - ✓ Les réflexes cutanés :
 - Le signe de Babinski est le signe le plus caractéristique d'une atteinte du faisceau pyramidal.
 - Les réflexes cutanés abdominaux et crémasteriens sont habituellement abolis.
- 6-2) Les paralysies de type périphérique :**
 - ✓ Sont en rapport avec une atteinte du motoneurone périphérique :
 - corne antérieure de la moelle.
 - racines rachidiennes, plexus ou nerfs moteurs.
 - ✓ Caractères communs :
 - Troubles moteurs :
 - Paralysie flasque avec hypotonie.
 - Abolition des ROT dans le territoire paralysé.
 - Amyotrophie souvent associée à des fasciculations.
 - Trouble vaso-moteurs : cyanose, refroidissement et trouble sudoraux.
 - Troubles sensitifs :
 - Subjectifs à type de douleurs ou paresthésies.
 - Et objectifs à type d'anesthésie complète portant sur tous les modes sensitifs.
- 6-3) Les troubles moteurs d'origine musculaire :** peuvent être de deux types
 - 6-3-1) Atteinte primitive des muscles ou myopathies qui associent :
 - Des paralysies progressives prédominant aux racines des membres.
 - Une atrophie musculaire, parfois une pseudo-hypertrophie.
 - L'absence de fasciculations.
 - L'absence de troubles sensitifs.
 - Des réflexes ostéo-tendineux qui peuvent être conservés.
 - L'abolition du réflexe idio-musculaire.
 - 6-3-1) Atteinte de la jonction neuro-musculaire ou myasthénie :
 - Qui est une fatigabilité à l'effort répété, qui régresse au repos.
 - Elle porte essentiellement sur :
 - Les muscles oculomoteurs : responsables de diplopie et d'un ptosis.
 - Les muscles masticateurs : avec gêne à la déglutition.
 - Les muscles des racines des membres.
- B. Syndromes extra-pyramidaux :**
 - ❖ **Le système extra pyramidal :**
 - ✓ Est annexé à la voie motrice principale et il aboutit au motoneurone périphérique.
 - ✓ Il est formé de noyaux gris centraux.
 - ✓ Son rôle est la régulation du tonus musculaire et son adaptation à la posture et au mouvement.

- ✓ Sa lésion, va se manifester par :
 - Des troubles de la motricité involontaire qui réalise des mouvements anormaux.
 - Associés à des troubles du tonus avec conservation de la motricité volontaire.
- ✓ Les syndromes extra-pyramidaux sont dominés par le syndrome parkinsonien.
- Les autres syndromes extra-pyramidaux sont plus rares : l'athétose, les dystonies, la chorée.

B-1) Le syndrome parkinsonien : est en rapport avec des lésions du locus niger, accessoirement du pallidum.

- ✚ Il est caractérisé par 3 signes : le tremblement parkinsonien, l'akinésie et l'hypertonie.

B-1-1) Le tremblement parkinsonien : est un tremblement de repos.

- C'est un mouvement rythmique régulier.
- Il prédomine aux extrémités distales.
- Il augmente d'amplitude avec les émotions, la fatigue et l'effort de concentration intellectuelle.
- Il disparaît lors du mouvement volontaire et pendant le sommeil.

B-1-2) L'akinésie : caractérisée par la réduction et la lenteur des mouvements.

- Le malade est spontanément immobile.
- Son expression gestuelle est appauvrie :
 - Au niveau du visage : on note une rareté du clignement et la réduction de la mimique qui donne au malade un masque figé, inexpressif, ne reflétant plus les émotions.
 - Lors de la marche, il existe une diminution du balancement des bras.

B-1-3) L'hypertonie : plastique et diffuse.

- Elle ne s'accompagne pas de déficit moteur et les ROT sont normaux.
- L'association de l'akinésie et de l'hypertonie est responsable de l'attitude générale en flexion du parkinsonien : la tête et le tronc sont inclinés en avant, les membres supérieurs demi-fléchis et en adduction, les genoux également demi-fléchis. (Q)



B-2) Le mouvement athétosique : est un mouvement involontaire lent et incessant, intéressant les extrémités des membres et la face.

- Aux membres supérieurs : il atteint surtout la main et les doigts : il s'agit de déplacements lents et asynchrones des doigts avec écartement et alternances de flexion extension des articulations métacarpo-phalangiennes.
- Aux membres inférieurs : on note une hyper-extension spontanée des orteils simulant un signe de Babinski.
- A la face : le mouvement athétosique siège au niveau de la région buccale réalisant des grimaces lentes.
- Le mouvement athétosique se développe sur un fond d'hypertonie, il est aggravé par la fatigue et les émotions.
- Il s'atténue au repos et disparaît pendant le sommeil.

B-3) Le mouvement choréique : elle est faite de mouvements involontaires, brusques, brefs, irréguliers, de grande amplitude (folie musculaire).

- Prédominant au cou et les racines des membres, se développe sur un fond hypotonie.
- Il est exagéré par l'émotion et mouvements volontaires.
- Amélioré par le repos et l'isolement et disparaît pendant le sommeil.
- Exemple de la chorée de Huntington d'origine dégénérative ou inflammatoire lors de la chorée de Sydenham dans le Rhumatisme articulaire aigu ;

B-4) Dystonies :

- ✓ Contractions toniques involontaires et intermittentes localisées à certains groupes musculaires.
- ✓ On distingue :
 - La dystonie d'attitude (hyperlordose, inflexion latérale, spasme de torsion).

- Le torticollis spasmodique :
 - est la forme la plus commune des dystonies.
 - rotation latérale, tête inhibée par un geste correcteur, un simple contact du doigt sur le menton.
- Les dystonies de la face.
- Les crampes fonctionnelles : la plus fréquente est la crampe des écrivains.

C. Mouvements anormaux et involontaires

C-1) Les tremblements (T) :

- + Sont les plus fréquents des mouvements anormaux.
- + **Définition** : des oscillations rythmiques involontaires de tout ou partie du corps autour de sa position d'équilibre.
- + Les différents types de tremblement : sont classés suivant leur circonstance d'apparition.
 - T d'attitude : n'apparaît que lors du maintien volontaire de l'attitude physiologique, ou exagéré par l'anxiété, éthylisme, thyrotoxicose ou familial.
 - T intentionnel : plus prononcé si membre dirigé vers un objet, disparaît au repos (syndrome cérébelleux).
 - T de repos (le syndrome Parkinsonien).

C-2) Myoclonies : sont des contractions musculaires brèves et involontaires, génératrices ou non de déplacement segmentaire.

C-3) Les tics :

- + Ce sont des mouvements involontaires qui se répètent à intervalle variable, sans motivation extérieure.
- + Habituellement selon le même type chez un sujet donné, mais variable d'un sujet à l'autre.
- + Ils ne s'accompagnent ni de troubles du tonus, ni de troubles de la motricité.
- + Le mouvement qui constitue le tic imite le mouvement volontaire; il peut d'ailleurs être reproduit volontairement.
- + Il s'agit le plus souvent de clins d'yeux, de grimaces, de haussement d'épaules, de mouvements du cou et de la tête.
- + L'apparition du tic est irrégulière et variable suivant l'état psycho-émotionnel du sujet, il peut être suspendu par la volonté ou lors du détournement de l'attention par une activité absorbante, il disparaît au cours du sommeil.
- + Valeur sémiologique : manifestation névrotique transitoire le plus souvent
plus rarement, il s'agit d'une séquelle d'encéphalite.